Der Bolam-Test

Englisches Deliktsrecht | Lernmaterial | Fachkompetenz, Behandlung und informierte Einwilligung

1. Ein fachlicher Vergleichsmaßstab

Übt der Beklagte besondere Fachkenntnisse aus oder nimmt sie für sich in Anspruch, wird regelmäßig mit einer vernünftig kompetenten Fachperson verglichen. Eine medizinische Behandlungsentscheidung wird nicht einfach danach beurteilt, was ein ungeschulter Laie tun würde. Höchste denkbare Expertise ist nicht verlangt, wohl aber die einschlägige fachliche Kompetenz.

Die Kenntnisse müssen zur betroffenen Tätigkeit passen. Historisches Fachwissen erhöht nicht automatisch den Maßstab bei einem gewöhnlichen Verkehrsunfall. Bei beruflichen Leistungen sind Aufgabe und Fachgebiet zu bestimmen; der Berufsabschluss verschärft nicht jede Handlung derselben Person.

2. Der Bolam-Grundsatz

Nach **Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582** liegt nicht schon deshalb Fahrlässigkeit vor, weil eine andere Fachgruppe anders entscheiden würde. Das Verhalten kann genügen, wenn es einer Praxis entspricht, die eine verantwortbare Gruppe einschlägig qualifizierter Fachleute als angemessen anerkennt.

Diese Gruppe muss nicht die zahlenmäßige Mehrheit bilden. Einzelne Unterstützer garantieren aber keine erfolgreiche Verteidigung. Die Auffassung muss verantwortbar und logisch begründbar sein; das präzisiert Bolitho.

3. Die Prüfung bleibt objektiv

Die Wahl des berufsspezifischen Maßstabs macht daraus keinen persönlichen Standard des Beklagten. „Hat dieser Arzt sein Bestes gegeben?“ oder „Hielt er es ehrlich für richtig?“ sind nicht die entscheidenden Fragen. Das Gericht vergleicht mit dem einschlägigen fachlichen Maßstab.

> Relevante Fachkenntnis → kompetente Fachperson → verantwortbare Berufspraxis → logische Kontrolle. Tatsachen bestimmen den passenden Maßstab; das macht den Test nicht rein subjektiv.

Namenskorrekturen: Bolam und Friern. Der fachgerechte Maßstab ist nicht einfach ein universeller „höherer Wert“ bei jeder Tätigkeit, sondern betrifft die konkret ausgeübte Kompetenz.

Bolam: der Ausgangsfall

1. Sachverhalt: Elektrokrampftherapie

Herr Bolam erhielt eine **Elektrokrampftherapie (ECT)**, bei der elektrischer Strom einen Krampfanfall auslöst. Dabei erlitt er schwere Knochenbrüche. Die Vorwürfe betrafen fehlende muskelentspannende Medikamente, den Umfang körperlicher Fixierung und die fehlende Warnung vor dem Bruchrisiko.

Die medizinischen Sachverständigen waren über die damals angemessene Praxis uneinig, auch über Risiken und Nutzen von Muskelrelaxanzien und Fixierung. Es ging somit nicht nur um Aufklärung, sondern auch um die Durchführung der Behandlung.

2. Wer gewann und warum?

Das beklagte Krankenhausverwaltungskomitee gewann. McNair J erläuterte den Geschworenen den fachlichen Standard und die Bedeutung verantwortbarer medizinischer Auffassungen. Die Geschworenen entschieden für die Beklagten. Die Verletzung allein bewies keine fahrlässige Behandlung.

Die Abweichung zwischen zwei verantwortbaren fachlichen Richtungen macht nicht schon eine davon fahrlässig. Umgekehrt schützt beruflicher Status nicht vor Haftung: Das tatsächliche Verhalten muss dem geforderten Standard entsprechen.

3. Heutige Verwendung des Falls

Bolam bleibt für klinische Diagnose und Behandlung bedeutsam, unter der Kontrolle nach Bolitho. Der historische Umgang mit Patientenwarnungen darf jedoch nicht als heutige allgemeine Regel informierter Einwilligung dargestellt werden. Montgomery verlangt eine eigenständige Prüfung wesentlicher Risiken und vernünftiger Alternativen.

Erfundenes Beispiel: Zwei Techniken werden jeweils durch verantwortbare, logisch begründbare Fachmeinungen gestützt. Die Wahl einer davon ist nicht allein deshalb breach, weil ein anderer Experte die zweite bevorzugt. Eine unsachgemäße Durchführung der gewählten Technik ist eine andere Frage.

> Drei Fragen trennen: War die klinische Methode fachlich vertretbar? Wurde sie kompetent ausgeführt? War der Patient angemessen informiert? Eine Antwort entscheidet nicht automatisch über die anderen.

Das Beispiel ist erfunden. Bolam betrifft medizinische Praxis der 1950er-Jahre. Der Sachverhalt ist Rechtsgeschichte, keine heutige medizinische Anleitung zur ECT.

Bolitho: logische Begründung

1. Das Gericht behält eine Kontrollfunktion

In **Bolitho v City and Hackney Health Authority [1998] AC 232** stellte das House of Lords klar: Ehrlich gegebene Expertenunterstützung ist nicht automatisch entscheidend. Die Fachauffassung muss eine logische Grundlage haben, insbesondere eine vertretbare Abwägung relevanter Risiken und Vorteile.

Das erlaubt Richtern nicht, medizinische Expertise durch persönliche Vorlieben zu ersetzen. Sind zwei Auffassungen logisch begründbar, genügt die bloße Ablehnung einer davon nicht. Eine Verwerfung kompetenter Fachmeinungen bezeichnete das Gericht als Ausnahme.

2. Sachverhalt und Ergebnis

Ein Kleinkind erlitt einen katastrophalen Atemstillstand. Eine Ärztin war nach Aufforderung fahrlässig nicht erschienen. Weiter war zu fragen, ob ihr Erscheinen zur Intubation geführt hätte und ob der Verzicht auf Intubation selbst fahrlässig gewesen wäre.

Die Gesundheitsbehörde gewann das Rechtsmittelverfahren. Die Fachauffassung gegen eine Intubation war nicht als unlogisch erwiesen. Die Kausalität des eingeräumten Nichterscheinens war nicht nachgewiesen: Bei einem vertretbaren Verzicht auf Intubation wäre der Zusammenbruch nicht verhindert worden.

3. Die Bedeutung für die Prüfung

Breach und Kausalität hängen zusammen, bleiben aber getrennte Fragen. Eine nachgewiesene fahrlässige Unterlassung beweist nicht ihre Schadensursächlichkeit. Umgekehrt kann ein Beklagter Kausalität nicht einfach mit der Behauptung entkräften, er hätte stattdessen eine andere Pflichtverletzung begangen.

Erfundenes Beispiel: Ein Experte unterstützt den Verzicht auf eine einfache Maßnahme, kann aber das Ignorieren einer bekannten schweren Gefahr nicht schlüssig begründen. Das Gericht darf die Verantwortbarkeit prüfen. „Ein Kollege stimmt mir zu“ ist nicht der vollständige Test.

> Bolam berücksichtigt verantwortbare Fachpraxis. Bolitho verlangt, dass diese logischer Analyse standhält. Beide Grundsätze garantieren keine Haftungsfreiheit bei beliebiger Expertenunterstützung.

Bolitho: Entscheidung 1997, veröffentlicht in [1998] AC 232. Ergänzende Präzisierung zum Transkript. Das Beispiel ist erfunden und keine weitere Feststellung des Falls.

Montgomery: Patientenentscheidung

1. Eine andere Frage: informierte Entscheidung

Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11 betraf eine Frau mit Diabetes, die nicht über das Risiko einer Schulterdystokie bei vaginaler Geburt informiert worden war: Die Schultern des Kindes bleiben stecken. Die Komplikation trat ein; ihr Sohn erlitt schwere Schäden.

Frau Montgomery gewann vor dem Supreme Court. Die Ärztin hätte das wesentliche Risiko und die Möglichkeit eines Kaiserschnitts besprechen müssen. Bei richtiger Aufklärung hätte die Mutter nach Feststellung des Gerichts einen Kaiserschnitt gewählt und die Verletzung vermieden.

2. Was ist ein wesentliches Risiko?

Ärzte müssen mit angemessener Sorgfalt über wesentliche Risiken empfohlener Behandlungen und vernünftige Alternativen informieren. Wesentlich ist ein Risiko, wenn eine vernünftige Person in der Lage des Patienten ihm voraussichtlich Bedeutung beimessen würde **oder** der Arzt weiß beziehungsweise vernünftigerweise wissen müsste, dass gerade dieser Patient dies tun würde.

Es zählt nicht nur, was andere Ärzte üblicherweise mitteilen. Geschützt wird die Patientenentscheidung. Es gibt einen allgemeinen patientenbezogenen und einen individuellen Bezug; die subjektive Präferenz des Arztes entscheidet nicht. Erforderlich ist verständlicher Dialog, nicht bloß eine Unterschrift.

3. Spätere Klarstellung: McCulloch

In **McCulloch v Forth Valley Health Board [2023] UKSC 26** verlangten Angehörige die Besprechung einer Medikamentenoption. **Die Gesundheitsbehörde gewann.** Welche Alternativen klinisch vernünftig sind, richtet sich nach fachlicher Praxis unter Bolitho-Kontrolle. Montgomery betrifft die Aufklärung über wesentliche Risiken und vernünftige Optionen. Nicht jede denkbare Behandlung muss angeboten werden.

> Klinische Diagnose/Behandlung: Bolam mit Bolitho-Kontrolle. Risikoaufklärung: Montgomery. Klinische Vernünftigkeit einer Alternative: fachliche Beurteilung, präzisiert in McCulloch.

Richtig: Lanarkshire, nicht Lancashire. Die Supreme-Court-Fälle stammen aus Schottland, prägen aber auch England und Wales. Enge Ausnahmen bei ernsthafter Gesundheitsgefahr durch Aufklärung oder dringender Notwendigkeit erlauben kein Verschweigen bloß zur Verhinderung einer Ablehnung.

Verständnisfragen

1. Warum vergleicht man Ärzte nicht mit ungeschulten Laien?
Antwort: Die Aufgabe erfordert Fachkompetenz. Maßgeblich ist eine vernünftig kompetente Person mit den relevanten beruflichen Fähigkeiten.

2. Macht der Fachmaßstab den Test subjektiv?
Antwort: Nein. Tatsachen bestimmen den Maßstab; persönliches Bestes oder ehrliche Überzeugung ersetzen den objektiven Standard nicht.

3. Wer gewann Bolam?
Antwort: Das Krankenhausverwaltungskomitee. Die Geschworenen entschieden nach Belehrung zum Fachmaßstab für die Beklagten; der Schaden allein bewies keine Fahrlässigkeit.

4. Garantiert ein unterstützender Experte die Verteidigung?
Antwort: Nein. Das Verhalten muss verantwortbarer, logisch begründbarer Berufspraxis entsprechen.

5. Was ergänzte Bolitho, und wer gewann?
Antwort: Die logische Grundlage der Fachmeinung darf gerichtlich geprüft werden. Die Behörde gewann, weil der Intubationsverzicht vertretbar und Kausalität nicht bewiesen war.

6. Wann ist ein Risiko nach Montgomery wesentlich?
Antwort: Wenn eine vernünftige Person in Patientenlage ihm wohl Bedeutung beimisst oder der Arzt dies vom konkreten Patienten wissen müsste. Einer der beiden Wege genügt.

7. Schaffte Montgomery Bolam für alle medizinischen Fragen ab?
Antwort: Nein. Es änderte die Risikoaufklärung. Klinische Urteile bleiben eigenständig; McCulloch betrifft vernünftige Alternativen.

> Prüfung: Aufgabe bestimmen → klinische Entscheidung und Aufklärung trennen → passenden Test wählen → Beweise und Begründungen prüfen → breach beurteilen → Kausalität und ersatzfähigen Schaden prüfen.

Quellen

Bearbeitung des Law-Academy-Transkripts mit Namenskorrekturen und rechtlichen Abgrenzungen. Ergänzungen: Bolitho und McCulloch. Primärentscheidungen: Bolam [1957] 1 WLR 582, 586-588; Bolitho [1998] AC 232. Montgomery [2015] UKSC 11, paras 87-90 and 103-105; McCulloch [2023] UKSC 26. Erfundenes ist gekennzeichnet.